E:表柔比星
C:环磷酰胺
T:紫杉醇/多西他赛

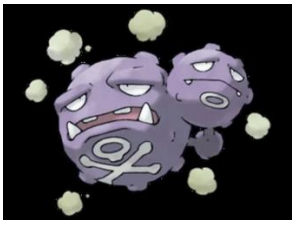
（二）化疗放疗

1.几乎要**化疗**（含紫杉醇的 TC/ETC 方案）抬杠

①浸润性癌伴腋淋巴结阳性

②腋淋巴结阴性但有高危复发因素：**＞2**cm、分化**差**、ER/PR-、*HER2*+（2 分之 2=1）

（除了 Luminal A 都得化疗）



2.放疗：保乳乳腺癌切除术后必须放疗

放疗不是只针对保乳乳腺癌切除术,如:
肿瘤很大,不是I/II期了,做不了改良根治术、保乳乳腺癌切除术,先放疗(减小肿块大小)
术后追加放疗减少复发出现

（三）ER+→内分泌治疗

①ttsx 绝经前用雌激素受体拮抗剂如**他莫昔芬/三苯氧胺**（吃他三）

②ttsx 绝经后用芳香化酶抑制剂如**阿那曲唑/依西美坦**（阿姨）

《生理学》：肾上腺皮质网状带分泌的雄激素，在脂肪组织等经芳香化酶→雌激素，是绝经后雌激素的主要来源

（四）*HER2*+→靶向治疗

曲妥珠单抗/赫赛汀（去喝）

VS 利妥昔单抗/美罗华:针对CD20+的单克隆抗体

二美丽

专题串联·乳房疾病鉴别

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

1.乳腺癌：＞40 岁多见，肿块多单发、无痛、质硬、边界不清、不易推动（炎性乳癌可无明显肿块，皮肤呈红肿等炎症样），**淋巴结无痛性肿大**，橘皮样变等→手术为主的综合治疗 炎性乳癌(区别于炎症)红肿,无明显肿块

2.乳腺纤维腺瘤

纤维组织多

①肿块多**单**发、**无**痛、质**硬**似像皮球，但肿块增长缓慢、边界清楚、易推动，淋巴结无肿大，20-25 岁多见

②切除肿瘤+常规病检（不能排除恶变）

天天师兄

3.乳腺囊性增生病 与月经周期有关,与雌激素有关 腺泡增生

①中年多见，**周期性乳房胀痛和颗粒样肿块**（结节大小不等、质韧），**月经后减轻**

（每个月总有那么几天乳房胀痛、有肿块，医生说这是乳腺增生病）

②对症治疗。症状重用他莫昔芬/三苯氧胺

③**定期复查**（是否恶变有争议）：若肿块无明显消退或可疑恶变→切除活检；若**中重度不典型增生、且对侧乳腺癌或乳腺癌家族史→单纯乳房切除术**

VS 炎性乳癌:中老年多见、不痛、无寒战高热、无血中白细胞增高

4.急性乳腺炎

乳腺癌淋巴结无痛性肿大

①**初产妇**多见，**红肿热痛、寒战高热**，多有患侧**淋巴结痛性肿大**，**血 WBC 高**

②乳汁淤积、细菌入侵（**金葡菌**经淋巴管多见）皮肤表面金葡菌多见

③排空 ttsx 乳汁 停止会加重乳汁淤积

④患侧停止、**健侧不停止**哺乳。若感染严重或脓肿引流后并发乳瘘→停止哺乳+溴隐亭

⑤苯唑西林等。禁用的抗生素有四环素（永久性牙变色）、磺胺类（核黄疸-磺胺与胆红素竞争血浆蛋白致 UCB 增加而侵犯脑）、喹诺酮类（影响软骨发育）、氨基糖苷类（耳毒性和肾毒性）四黄同堂